

Oberlidkorrektur

Eine Oberlidkorrektur kann störenden Hautüberschuss an den oberen Augenlidern reduzieren. Wir untersuchen zuvor, ob tatsächlich die Lidhaut, eine abgesunkene Augenbraue oder eine Schwäche des Lidhebemuskels für den Befund verantwortlich ist.

Wann die Behandlung sinnvoll sein kann

Mögliche Gründe sind ein störender Hautüberschuss, ein Schweregefühl oder eine durch überhängende Lidhaut eingeschränkte Sicht. Bei funktionellen Beschwerden kann zusätzlich eine augenärztliche Untersuchung einschließlich Gesichtsfeldprüfung notwendig sein.

Eine abgesunkene Braue und eine echte Lidhebeschwäche (Ptosis) können ähnlich aussehen, benötigen aber gegebenenfalls ein anderes Vorgehen. Augenstellung, Lidschluss und bereits bestehende Asymmetrien werden in die Planung einbezogen.

Wie wir operieren

Vor dem Eingriff markieren wir den zu korrigierenden Bereich. Über einen Schnitt in der natürlichen Oberlidfalte wird überschüssige Haut sparsam entfernt. Falls der individuelle Befund es erfordert, kann zusätzlich vorgewölbtes Fettgewebe angepasst werden. Wir erhalten ausreichend Gewebe für einen sicheren Lidschluss und schließen die Wunde mit feinen Nähten.

Die Behandlung erfolgt üblicherweise ambulant in örtlicher Betäubung. Umfang, Seite bzw. beidseitiges Vorgehen und ergänzende Maßnahmen werden vorher persönlich besprochen.

Was die Operation nicht verspricht

Ziel ist ein zum Gesicht passendes Ergebnis unter Erhalt der Lidfunktion. Vollständige Symmetrie, unsichtbare Narben oder ein dauerhaft unverändertes Aussehen lassen sich nicht garantieren. Krähenfüße, Augenringe und Brauenabsenkung werden durch eine reine Oberlidkorrektur nicht zuverlässig beseitigt.

Zeit für Ihre Entscheidung Es handelt sich um eine geplante Behandlung. Abwarten oder der Verzicht auf eine Operation sind mögliche Alternativen. Nichtoperative Hautbehandlungen können andere Ziele verfolgen, ersetzen bei deutlichem Hautüberschuss aber nicht ohne Weiteres dessen operative Entfernung.

Vor der Operation

- Bitte berichten Sie über trockene oder gereizte Augen, Kontaktlinsen, Sehprobleme, frühere Augen- oder Lidoperationen, Glaukom sowie Schilddrüsenerkrankungen. Bei Bedarf erfolgt vorab eine augenärztliche Abklärung.
- Wir beurteilen Lidhaut, Brauenposition, Lidschluss und Augenoberfläche. Vorbestehende Trockenheit oder ein eingeschränkter Lidschluss können die Planung ändern oder gegen den Eingriff sprechen.
- Alle Medikamente und Nahrungsergänzungen angeben, insbesondere Blutverdünner. Verordnete Medikamente niemals eigenständig pausieren; Änderungen stimmen wir gegebenenfalls mit der behandelnden Praxis ab.
- Aktive Infektionen oder Entzündungen im Operationsgebiet müssen zunächst behandelt werden. Rauchen beeinträchtigt die Wundheilung; besprechen Sie eine Rauchpause vor und nach dem Eingriff.
- Am Behandlungstag ohne Augen-Make-up und Kontaktlinsen kommen. Abholung organisieren: Schwellung, Salbe und vorübergehend unscharfes Sehen können die Orientierung beeinträchtigen.

Risiken und mögliche Komplikationen

Schwellungen, Blutergüsse, Spannungsgefühl, vorübergehende Taubheit, Tränen oder Trockenheitsgefühl sind möglich. Allgemeine Operationsrisiken sind Nachblutung, Infektion, Wundheilungsstörung, auffällige Narben und Unverträglichkeiten von Medikamenten oder Betäubungsmitteln.

Spezifisch können Asymmetrien, eine veränderte Lidfalte, kleine Narbenzysten, unzureichende oder zu starke Gewebeentfernung und ein unvollständiger Lidschluss entstehen. Dies kann die Augenoberfläche austrocknen und die Hornhaut schädigen. Manche Beschwerden erfordern Augentropfen, weitere augenärztliche Behandlung oder eine Korrekturoperation.

Selten treten anhaltende Lidfunktionsstörungen, Doppelbilder oder andere Sehstörungen auf. Sehr selten kann eine Blutung hinter dem Auge den Sehnerv gefährden und bis zum dauerhaften Sehverlust führen. Individuelle Risiken und notwendige Sofortmaßnahmen besprechen wir vor dem Eingriff.

■ **Sehstörung ist ein Augen-Notfall:** Bei plötzlich schlechterem Sehen, starken Augenschmerzen oder rasch zunehmender einseitiger Schwellung sofort augenärztliche Notfallversorgung aufsuchen. Parallel unsere Praxis verständigen; nicht auf einen Rückruf warten und nicht selbst fahren.

Risiken der Betäubung

Örtliche Betäubungsmittel können unter anderem Blutergüsse, vorübergehende oder selten anhaltende Gefühlsstörungen, allergische Reaktionen und bei unbeabsichtigter Gefäßinjektion Kreislauf- oder Herzrhythmusstörungen verursachen. Sedierung und Narkose können Atmung und Kreislauf beeinträchtigen; außerdem sind Übelkeit, Erbrechen, Aspiration sowie Verletzungen durch Atemwegssicherung möglich. Schwere Komplikationen sind selten. Bei geplanter Sedierung oder Narkose erfolgt eine gesonderte individuelle Aufklärung.

Heilung und Verhalten danach

- Kühlen Sie behutsam in kurzen Intervallen mit einem eingewickelten Kühlmittel. Kein Eis direkt auf die Haut und keinen Druck auf das Auge ausüben. Den Kopf beim Ruhen etwas erhöht halten.
- Wunden nicht reiben oder selbst behandeln. Verordnete Salben oder Augentropfen nur nach Anleitung verwenden. Bei unvollständigem Lidschluss oder zunehmender Trockenheit frühzeitig melden.
- Bücken, Pressen, schweres Heben und anstrengenden Sport zunächst vermeiden, häufig für etwa zwei Wochen. Die Freigabe richtet sich nach dem Heilungsverlauf.
- Kontaktlinsen und Augen-Make-up erst nach sicherer Wundheilung und ärztlicher Freigabe verwenden. Brille ist zunächst oft angenehmer.
- Nicht selbst fahren, solange Sehen oder Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt sind. Nach Sedierung oder Narkose gelten zusätzlich die vereinbarten Einschränkungen.

Zeitlicher Verlauf

Erste Tage: Schwellung und Blutergüsse können zunächst zunehmen. **Nach etwa ein bis zwei Wochen:** Fäden werden nach Befund entfernt; sichtbare Veränderungen klingen oft deutlich ab. **Folgende Wochen bis Monate:** Narben und Restschwellungen reifen weiter. Das endgültige Ergebnis wird erst im Verlauf beurteilt.

Planen Sie gesellschaftliche Termine mit Reserve. Sonnenschutz der abgeheilten Narbe und eine Sonnenbrille unterstützen die Schonung; direkte UV-Belastung vermeiden. Kontrolltermine auch bei gutem Verlauf wahrnehmen.

Schmerzen und Warnzeichen

Leichte Beschwerden lassen sich meist mit einem individuell empfohlenen Schmerzmittel behandeln. Nehmen Sie keine zusätzlichen Schmerzmittel oder ASS zur Selbstbehandlung ohne Rücksprache; bereits ärztlich verordnetes ASS oder andere Blutverdünner nicht selbst absetzen.

Zunehmende Rötung, Eiter, Fieber, Wundöffnung oder anhaltende Blutung bitte zeitnah melden. Starke oder rasch zunehmende Schmerzen sind kein gewöhnlicher Heilungsverlauf.

■ **Sehstörung ist ein Augen-Notfall:** Bei plötzlich schlechterem Sehen, starken Augenschmerzen oder rasch zunehmender einseitiger Schwellung sofort augenärztliche Notfallversorgung aufsuchen. Parallel unsere Praxis verständigen; nicht auf einen Rückruf warten und nicht selbst fahren.

Bei zunehmenden Beschwerden bitte sofort melden: Praxis 06151 786540; außerhalb der Praxissprechzeiten +49 151 10437450. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: 112.

Häufige Frage

Kann das Ergebnis später wieder nachlassen? Ja. Der natürliche Alterungsprozess setzt sich fort. Ob und wann eine weitere Behandlung sinnvoll ist, hängt vom Befund ab.

Betäubung und Komfortmöglichkeiten

Standard ist die Lokalanästhesie. Zusätzliche Sedierung oder Narkose wird individuell vereinbart und erfordert eine gesonderte Beurteilung.

Methode	Beschreibung	Kosten
Lokalanästhesie Standard	Wach, kein Schmerz – nur Druck. Bei Schmerzwahrnehmung wird sofort nachbetäubt. Nach reiner Lokalanästhesie sind ÖPNV grundsätzlich möglich; bei beeinträchtigtem Sehen ist eine Begleitung erforderlich.	Im individuell vereinbarten Behandlungspaket enthalten.
Orale Sedierung (Tavor) Komfort	Tablette ca. 60 Min. vorher. Kein Schlaf, deutliche Stressreduktion. Vitalparameter werden überwacht. Begleitperson notwendig, 24 Std. nicht verkehrsfähig. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 80 € Eigenleistung
Dämmerschlaf (i.v.) Komfort	Professionelles Narkoseteam, medikamentös an der Schlaf-Wachgrenze, kooperativ, meist keine Erinnerung. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern ab 22 Uhr nichts essen, ab 6 Uhr nichts trinken. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 230 € Eigenleistung
Vollnarkose Komfort	Echter Tiefschlaf, Beatmung über die Nase in die Lunge, keine Wahrnehmung des Eingriffs. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern wie Dämmerschlaf. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 450 € Eigenleistung

Sicher nach Hause Vor Beginn wird die Wirkung der örtlichen Betäubung geprüft; bei Schmerzen wird sofort nachbetäubt. Sedierung ist eine optionale Komfortzubuchung. Nach Sedierung oder Narkose sind Abholung und 24 Stunden Verzicht auf aktive Teilnahme am Straßenverkehr erforderlich. Auch nach reiner Lokalanästhesie empfehlen wir wegen möglicher Seheinschränkungen eine Begleitperson. Persönliche Nüchtern- und Medikamentenanweisungen haben Vorrang.

Kosten und Checkliste

Ästhetische Oberlidkorrekturen sind **individuell vereinbarte Eigenleistungen**. Bei medizinischer Indikation muss eine mögliche Kostenübernahme vor der Behandlung mit der Versicherung geklärt werden; eine Zusage besteht nicht automatisch. Sie erhalten vorab eine Kostenvereinbarung.

- Befund, Behandlungsziel und Grenzen verstanden?
- Augenerkrankungen, Medikamente, Allergien und Voroperationen angegeben?
- Abholung, Erholungszeit und Kontrolltermine organisiert?
- Individuelle Risiken, Betäubung und Kosten besprochen?



QR-Code mit dem Smartphone scannen
<https://patienteninfo.mkg-im-carree.de/oberlidkorrektur/>

Weiterführende Quellen

DGPRÄC: Augenlidstraffung

NHS: Eyelid surgery

Cambridge University Hospitals: Blepharoplasty

Royal Free London: Nachsorge und Augen-Warnzeichen